

Faringoamigdalitis y Otitis Media

1. Introducción y relevancia clínica

La **faringoamigdalitis aguda** y la **otitis media aguda (OMA)** son dos de las infecciones respiratorias altas más comunes en la práctica clínica, especialmente en pediatría y atención primaria. Aunque la mayoría de los casos tienen **etiología viral**, un porcentaje significativo es causado por bacterias, siendo **Streptococcus pyogenes (estreptococo beta-hemolítico del grupo A)** el agente más relevante en faringoamigdalitis y **Streptococcus pneumoniae** el más frecuente en otitis media.

El principal desafío clínico consiste en **distinguir entre causas virales y bacterianas**, para evitar el uso inadecuado de antibióticos. El diagnóstico correcto permite prevenir complicaciones graves como **fiebre reumática**, **glomerulonefritis postestreptocócica** o **mastoiditis**.

Ambas patologías son motivo frecuente de preguntas en el **EUNACOM**, donde se evalúan criterios diagnósticos, indicaciones de antibióticos, complicaciones y medidas preventivas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Faringoamigdalitis aguda

Es un proceso inflamatorio que compromete la mucosa faríngea y las amígdalas palatinas.

La infección puede deberse a **virus respiratorios comunes** (adenovirus, rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, Epstein-Barr) o a **bacterias**, principalmente *Streptococcus pyogenes* (grupo A).

El estreptococo produce exotoxinas pirogénicas responsables de fiebre y eritema, además de antígenos (proteína M) que pueden inducir reacciones autoinmunes, explicando complicaciones no supurativas como **fiebre reumática** y **glomerulonefritis postestreptocócica**.

La transmisión es por **vía respiratoria** o por contacto directo con secreciones orales, con un período de incubación de 2 a 5 días. Es más frecuente en niños entre 5 y 15 años y en invierno.

Otitis media aguda

Es una infección del oído medio, generalmente secundaria a una infección respiratoria alta, que causa inflamación de la mucosa y acumulación de líquido purulento en la cavidad timpánica.

Se produce por disfunción de la **trompa de Eustaquio**, que facilita el paso de patógenos desde la nasofaringe hacia el oído medio.

Los principales agentes etiológicos son:

- **Streptococcus pneumoniae**
- **Haemophilus influenzae no tipificable**
- **Moraxella catarrhalis**

En lactantes menores, también pueden encontrarse *Streptococcus pyogenes* y *Staphylococcus aureus*.

Los virus respiratorios predisponen a la otitis al alterar el aclaramiento mucociliar y favorecer la colonización bacteriana.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Faringoamigdalitis viral

Es la forma más frecuente.

Los síntomas suelen ser leves: odinofagia, rinorrea, tos, disfonía, conjuntivitis y febrícula.

El examen físico muestra **hiperemia difusa de la faringe**, sin exudado purulento, y ganglios cervicales pequeños y móviles.

Puede haber úlceras faríngeas o vesículas en la mucosa (faringoestomatitis herpética).

3.2. Faringoamigdalitis estreptocócica (bacteriana)

Se caracteriza por un cuadro súbito con **fiebre alta, odinofagia intensa, cefalea y malestar general marcado**.

No hay tos ni rinorrea (lo que orienta a origen bacteriano).

El examen físico revela **amígdalas aumentadas de tamaño, eritematosas y con exudado blanquecino**, además de **adenopatías cervicales dolorosas**.

Puede presentarse petequias en el paladar y halitosis.

Comentario EUNACOM:

Niño con fiebre alta, odinofagia y ausencia de tos → sospechar *S. pyogenes*.

El cuadro se resuelve espontáneamente en 3–5 días, pero el tratamiento antibiótico es fundamental para prevenir **fiebre reumática**.

3.3. Escalas diagnósticas (criterios de Centor modificados)

La probabilidad de infección estreptocócica aumenta según el número de criterios presentes:

1. Fiebre >38 °C
2. Ausencia de tos
3. Exudado o hipertrofia amigdalas
4. Adenopatías cervicales anteriores dolorosas
5. Edad entre 3 y 14 años (+1 punto)
6. Edad >44 años (-1 punto)

Interpretación:

- 0–1 puntos: bajo riesgo → manejo sintomático.
 - 2–3 puntos: solicitar test rápido o cultivo.
 - 4 o más puntos: iniciar antibiótico empírico.
-

3.4. Otitis media aguda (OMA)

Generalmente comienza tras una infección respiratoria alta.

Los síntomas principales son:

- **Otalgia** (a menudo intensa y de inicio súbito)
- **Fiebre**
- **Irritabilidad o llanto en lactantes**
- **Disminución de la audición transitoria**

El diagnóstico se confirma con **otoscopía**:

- Membrana timpánica **eritematosa, abombada y opaca**, con pérdida del reflejo luminoso.
- Disminución o ausencia de movilidad al realizar neumotoscopía.
- En casos complicados puede haber **otorrea** por perforación timpánica.

Complicaciones: mastoiditis, absceso subperióstico, parálisis facial o meningitis.

3.5. Diagnóstico diferencial

Faringoamigdalitis: mononucleosis infecciosa, difteria, candidiasis oral, herpangina, absceso periamigdalino.

Otitis media: otitis externa, barotrauma, otalgia referida por faringitis o disfunción temporomandibular.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Faringoamigdalitis

- En la mayoría de los casos, el diagnóstico es clínico.
 - Se recomienda el **test rápido de detección de antígeno estreptocócico** en casos dudosos.
 - Si el test no está disponible, puede realizarse **cultivo faríngeo**, que es el estándar de oro, aunque demora 24–48 horas.
 - No se requieren exámenes complementarios en casos típicos leves.
 - En sospecha de mononucleosis, se puede solicitar hemograma (linfocitosis y linfocitos atípicos) y test de Paul-Bunnell (Monospot).
-

Otitis media

- Diagnóstico clínico con otoscopia.
 - La timpanometría puede confirmar la presencia de líquido en oído medio.
 - No se recomiendan radiografías ni TAC salvo en complicaciones.
 - En otitis recurrente o complicada, puede solicitarse cultivo de secreción ótica.
-

5. Tratamiento (según Guías MINSAL y SOCHINF 2023–2024)

5.1. Faringoamigdalitis viral

Tratamiento sintomático:

- Paracetamol o ibuprofeno para fiebre y dolor.
 - Hidratación y reposo.
 - Evitar antibióticos.
 - En casos con congestión nasal, puede usarse solución salina o analgésicos tópicos.
-

5.2. Faringoamigdalitis estreptocócica

El objetivo del tratamiento es **erradicar el estreptococo y prevenir fiebre reumática**.

Antibiótico de elección:

- **Penicilina benzatina IM**, dosis única:
 - Adultos: 1,2 millones UI IM.
 - Niños: 600.000 UI IM (<27 kg) o 1,2 millones UI (>27 kg).

Alternativa:

- **Amoxicilina oral** 50 mg/kg/día (máx. 1 g/día) por 10 días.

En alérgicos a penicilina:

- **Eritromicina** 40 mg/kg/día o **azitromicina** 12 mg/kg/día por 5 días.

Medidas complementarias:

- Analgésicos y líquidos tibios.
- Evitar contacto con otros niños por 24 h después de iniciar antibiótico.

Comentario EUNACOM:

Ante faringoamigdalitis con exudado y ausencia de tos → iniciar penicilina benzatina sin esperar cultivo.

5.3. Otitis media aguda

A. Manejo general

- Analgesia: paracetamol o ibuprofeno.
- Control clínico a las 48–72 h.
- En lactantes <6 meses o con síntomas graves (fiebre >39 °C, otalgia intensa, bilateralidad): iniciar antibiótico inmediato.
- En mayores de 2 años con síntomas leves, puede optarse por **observación vigilada** (watchful waiting) durante 48 h antes de iniciar antibiótico.

B. Antibióticos

- **Amoxicilina** 80–90 mg/kg/día en 2 dosis por 10 días.
- Si no hay mejoría en 48–72 h, o sospecha de resistencia:
 - **Amoxicilina + ácido clavulánico**.
- En alérgicos: **azitromicina** o **claritromicina**.

C. Casos especiales

- Si hay perforación timpánica: agregar gotas óticas antibióticas (ciprofloxacino).
- En recurrencias (>3 episodios en 6 meses): derivar a otorrinolaringología.

6. Complicaciones y pronóstico

Faringoamigdalitis

- **Supurativas:** absceso periamigdalino, absceso retrofaríngeo, otitis media, sinusitis.
- **No supurativas:** fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica.

La fiebre reumática puede afectar corazón, articulaciones y sistema nervioso, por lo que el tratamiento precoz con penicilina es esencial.

El pronóstico es excelente con manejo adecuado.

Otitis media

- **Locales:** mastoiditis, absceso subperióstico, parálisis facial periférica, laberintitis.
- **Sistémicas:** meningitis, absceso cerebral (raras en era antibiótica).

En general, el pronóstico es bueno, aunque puede haber **otitis media serosa residual o pérdida auditiva conductiva temporal**.

7. Prevención

- **Lavado de manos y control de infecciones respiratorias** en guarderías y colegios.
- **Vacunación antineumocócica e influenza** según el calendario nacional.
- Evitar exposición al humo del tabaco.
- Promover lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses (protege contra OMA).
- Tratar alergias y rinitis crónica para prevenir otitis recurrente.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. En faringoamigdalitis, la **ausencia de tos y presencia de fiebre y exudado** orientan a origen estreptocócico.
2. La **penicilina benzatina en dosis única** es el tratamiento de elección.
3. En otitis media, **amoxicilina a dosis altas** es la primera elección.
4. En mayores de 2 años con síntomas leves, se puede observar antes de usar antibióticos.
5. En EUNACOM, si hay faringoamigdalitis con exudado purulento y fiebre alta → penicilina inmediata.

6. La **mastoiditis** es la complicación más temida de la OMA no tratada.
7. La **fiebre reumática** es la complicación más grave de la faringoamigdalitis estreptocócica.

Errores frecuentes:

- Usar antibióticos en cuadros virales.
 - No completar 10 días de tratamiento.
 - No reconocer un absceso periamigdalino (trismus, desviación de úvula).
 - Omitir derivación en otitis media complicada o recurrente.
 - Indicar amoxicilina a dosis bajas (ineficaz frente a cepas resistentes).
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **faringoamigdalitis** y la **otitis media** son infecciones respiratorias comunes, habitualmente virales, pero potencialmente bacterianas.
2. El principal agente bacteriano en faringoamigdalitis es *Streptococcus pyogenes*, cuyo tratamiento previene fiebre reumática.
3. En otitis media, los agentes más frecuentes son *S. pneumoniae*, *H. influenzae* y *M. catarrhalis*.
4. El **diagnóstico clínico** es suficiente en la mayoría de los casos; los test rápidos confirman infección estreptocócica.
5. El tratamiento de elección es **penicilina benzatina IM** (faringitis) y **amoxicilina VO** (otitis).
6. Las complicaciones incluyen abscesos, fiebre reumática y mastoiditis.
7. En **EUNACOM**, suelen preguntar por la **conducta antibiótica correcta según el cuadro clínico** y la **prevención de complicaciones**.